



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : غاده محمد محمد على
المحافظة : الجيزة
رقم البطاقة : 27202150101429 رقم التليفون : 01147260510
العنوان : ممممممممممممممم
العمر (تاريخ الميلاد) : 15-02-1972 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----
قسم : -----
نفقات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: غاده محمد محمد علي National ID: 27202150101429	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

غاده
محمد محمد علي
قرية بهر مس
منشأة القناطر - الجيزة

٢٧٢٠٢١٥٠١٠١٤٢٩

JV2155733

٢٠٢٢/٠١ (٢٧٢٠٢١٥٠١٠١٤٢٩)
حاصلة على دبلوم تجارة

أنثى مسلمة متزوجة
مجدى عبدالمعزم محمد عبد الله

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٠/٠١/٠١



Patient Name: Ghada Mohamed Mohamed Ali	Date : 01/03/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 53 Year(s)
Medical ID: 3393/2020	Pat. ID: 32464

**DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

Technique

- Right MLO and CC views
- Left MRM & breast ultrasound

Report:

Left MRM:

- Operative bed shows no mass or collection
- No regional lymphadenopathy.

Right breast:

- Predominant Fatty parenchyma (ACR b)
- Benign scattered loosely attached calcifications.
- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Complementary ultrasound dilated retro-areolar ducts one of them show focal ductal dilatation with echogenic content measures 1 x 2.3 cm yet no internal vascularity stationary since 2021.
- Normal skin thickness and nipple-areola complex .
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left MRM status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Right breast retro areolar focal ductal dilatation stationary since 12.2021 (BIRADS 2)

Signature Dr. Youmna tarek

01/03/2025 1:36 PM

Name:	غاده محمد محمد	
MR. :	2739	
Detailed Medical Report		
		السيد
تخية طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient is a 53-year-old postmenopausal individual with a known left-sided invasive ductal carcinoma (IDC) of the breast. Family history is positive for breast cancer in the mother and grandmother. The tumor was strongly estrogen- and progesterone-receptor positive (ER/PR ++), HER2 equivocal (2+) with documented amplification. Initial clinical staging was cT3N1. Neoadjuvant chemotherapy consisting of an anthracycline/taxane backbone combined with anti-HER2 therapy was administered, followed by left modified radical mastectomy in April 2024. Final pathology demonstrated pT1N1 disease. Post-operative radiotherapy was completed, and adjuvant anti-HER2 therapy (trastuzumab ± pertuzumab) was given through December 2021. The patient has been on an aromatase inhibitor (Arimidex) since May 2021, now ongoing for approximately seven years, with recent serum markers, physical examination, and full laboratory workup performed today. In May 2026 the multidisciplinary team extended the duration of aromatase-inhibitor therapy by two years and added Zometa (zoledronic acid) to be administered every six months. Breast imaging in May 2026 showed a BIRADS 2 finding, and abdominal ultrasound revealed a fatty liver. The current regimen includes Arimidex with supportive care for the past three months. The next clinic visit is scheduled for 26 August 2026. The patient continues on the prescribed aromatase inhibitor and bisphosphonate therapy as outlined.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 19-09-2026
	علياء احمد أبو النصر شهاب الدين	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Patient Name: Ghada Mohamed Mohamed Ali	Date : 09/04/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 51 Year(s)
Medical ID: 3393/2020	Pat. ID: 32464

**DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY
ULTRASOUND**

Technique

- Right MLO and CC views
- Left MRM & breast ultrasound

Report:

- Left MRM:
 - Operative bed shows no mass or collection
 - No regional lymphadenopathy.
- Right breast:
 - Predominant Fatty parenchyma (ACR b)
 - Benign scattered loosely attached calcifications.
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound dilated retraareolar ducts one of them show focal ductal dilatation with echogenic content measures 1 x 2.3 cm yet no internal vascularity stationary since 2021.
 - Normal skin thickness and nipple-areola complex .
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left MRM status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Right breast retro areolar focal ductal dilatation stationary since 12.2021 BIRADS 2

Signature Dr. Aya Deabes

09/04/2023 12:56 PM

مركز أرواح دار السلام
عروم ساسا

Name : GHADA MOHAMED

Date : 27-08-2020

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS WITH CORONAL RECONSTRUCTION: -**

Chest:

- Ill defined left breast lower quadrant enhancing soft issue lesion is seen measuring about 3.1x18mm cm with few prominent left axillary lymph nodes.
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

Abdomen:

- The liver is enlarged in size with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Multiple dense stones are seen in the gall bladder.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Reviewing skeletal parts revealed no lytic or sclerotic osseous lesions.

OPINION:

- ***Ill defined left breast skin related soft issue density with few prominent left axillary lymph nodes.***
- ***No evidence of pulmonary nodules or hepatic focal lesions.***
- ***Calcular gall bladder.***
- ***No lytic or sclerotic osseous lesions.***

DR, Ibrahim Elsedawy.M.Sc, FEBR

Dr.m.gomaa,md



Report

Patient Name:	Ghada mohammad mohammad Ali	Patient Age:	2019
Patient Code:	Q26135	DATE	11/15/2020 2:12:31 PM

Tc^{99m} MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

Clinical history

- Female patient with history of left breast mass and pathology revealing invasive duct carcinoma.

Technique

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post IV injection of 740 MBq of the tracer.

Findings

- No abnormal osseous tracer uptake is seen that would account for bone deposits.
- Degenerative changes of the spine are noted.
- Osteoarthritic changes of the both knees are seen.

Opinion

- The surveyed skeleton is free from metastatic osseous lesions.

Dr. Eman Ashraf, MSc

Prof. Ahmed Kandeel, MD



Pathology Report

Name: غاده محمد محمد علي

Age: 48 years.

Clinical data: Known case of invasive duct carcinoma grade 2, post chemotherapy.

Specimen type: Left modified radical mastectomy (MRM).

Date (Received): 4/4/2021

Date(reported): 12/4/2021

Lab. Number: 718 /21

Hospital Number: 3393/2020

Gross Description:

Left MRM measuring 28x18x2cm, with covering skin piece containing nipple and areola (unremarkable grossly) measuring 20x11cm. Cut section revealed an ill defined greyish white firm mass at lower inner quadrant measuring 1.5x1x1cm, away from the deep margin (least margin) by 2cm. There are scattered greyish white thickenings all over the breast.

Axillary dissection revealed 11 lymph nodes up to 1cm.

Microscopic picture:

Histopathological examination of sections prepared from the specimen received reveals an infiltrating malignant epithelial growth. The tumour is made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate [grade II], focal insitu components can be detected. There are positive lymphovascular emboli and perineural invasion. Positive metastatic deposits in (2/11) axillary lymph nodes, no extracapsular extension. Nipple, areola, skin and soft tissue margins are free.

Diagnosis:

Invasive duct carcinoma grade 2, with focal insitu components.

Partial pathological response (PPR).

Tumour necrosis index +/-35%

Positive lymphovascular emboli and perineural invasion.

Positive metastatic deposits in (2/11) axillary lymph nodes, no extracapsular extension.

Free nipple, areola, skin and soft tissue margins.

Stage: ypT1, ypN1, ypMx

Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Enas Mohammed Ali
Dr. Abdulrahman Ibrahim



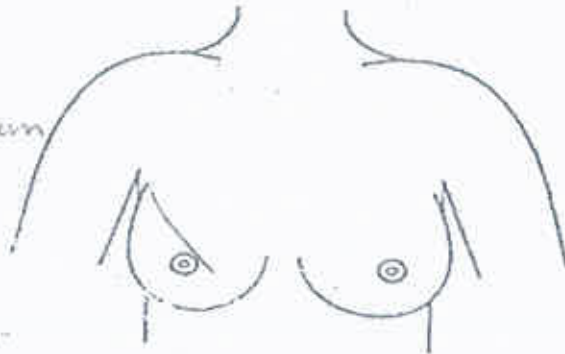
وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
هرمل، سابقا

Name: غادة محمد توفيق
Age: 42 yrs
No.: _____

MDT FORM

Clinical data :

PT, N1, Mo, cT3
(1.5x1.5) (1.1/1.1)
bone scan



Hx case + Lt breast ca IDC II (Triple positive)
MRM done after NACT 4AC/4Taxol + herceptin
MRM + ALND done on 4/4/2021

Reason of discussion: pathology report revealed
Partial pathological
response.
for adjuvant herceptin
S.C.

MDT Outcome and Plan

د/ سحر لاس

د/ ياسر رافع

Signature : د/ اسماء الطرعي

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m4202

Female :	النوع	غادة محمد محمد	اسم المريض
12/08/2020 14:16 :	التاريخ	48 Y	العمر
24/08/2020 09:46 :	تاريخ استلام العينة		تاريخ اخذ العينة
	تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	مكتب التحليل
		مركز اورام دار السلام	طالبة

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by : - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody
Sample recieved was treated by : - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.
Sample recieved was treated by : - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: strong nuclear staining of > 60 % of tumour cells (core biopsy)
PR: strong nuclear staining of > 60 % of tumour cells (core biopsy)
HER2/neu protein over expression : moderate continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells (core biopsy)
Ki67: positive nuclear staining of about 15 % of tumour cells (core biopsy)

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 8/8)
PR: POSITIVE (SCORE 7/8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : EQUIVOCAL (SCORE 2 +)
#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 15 %

Pathologist:

د/عزيزا ماهر

Lab Director:

د/عزيزا ماهر

24/8

2020

19 El-shekh Rehan Street, Abideen, Cairo
Tel: (165)7948544 - 7950098 Fax: (202)7948544
Mobile : 01144297292
website: <http://www.healthlabs.net>
email: pathtologychi@yahoo.com

قسم الباثولوجي - الادارة المركزية للمعامل

This Test Is Not Accredited By EGAC Nor Recognized By ILA

يتم الاحتفاظ بالأسل العينة لمدة 30 يوم من تاريخ استلامها